随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

四、分类

感性认识“温柔”

1.小结节性/门脉性肝硬化/酒精性肝硬化：再生结节多≤3mm、大小相仿，纤维间隔细，并发食管胃底静脉曲张破裂出血的机率高

门脉压力非常高→开放侧支循环如食管胃底静脉→静脉曲张破裂出血

感性认识“大坏蛋”

2.大结节性/坏死后性肝硬化

①再生结节多＞3mm、大小不均，纤维间隔宽而不均，并发肝性脑病的机率高

肝细胞坏死多→解毒氨气能力↓→发展为肝性脑病

②亚急性重型肝炎、中毒性肝炎所致大坏蛋

❌急性重型肝炎来不及修复,没有纤维化,不往肝硬化发展

广泛增生的胶原纤维重新分割肝小叶

注意：假小叶不是肉眼所见的肝表面结节，假小叶就是大小不等的

但肉眼所见的结节：

①可以相仿（小结节性肝硬化）

②可以不等（大结节性肝硬化）

③可以没有明显结节（淤胆、淤血、淤虫）

五、肝硬化的临床表现

（一）肝功能障碍

①白蛋白合成障碍→低蛋白血症→血浆胶渗压↓，白/球蛋白↓或倒置

通过NO导致CAP扩张

②雌激素灭活减弱→蜘蛛痣、肝掌、睾丸萎缩、乳房发育、ttsx 月经不调

③凝血因子合成↓（主要）、脾亢致血小板↓等→出血倾向 门脉高压导致脾大脾亢

压迫胆管影响胆汁正常排泄

④肝处理胆红素障碍、小叶结构改变致淤胆→黄疸

⑤肝肾综合征 临床:肝硬化低蛋白血症→组织液生成增多→组织水肿、腹水→有效循环血量↓→GFR↓肾衰竭

⑥肝性脑病/肝昏迷（最严重）：氨中毒、门-腔侧支循环分流等

最重要　血液未经肝脏解毒直接流入体循环



短期雄激素雌激素灭活均↓,但增多的雄激素通过芳香化酶变成雌激素→雌激素↑↑→负反馈使雄激素↓→最终雌激素↑雄激素↓